Apendicitis y signos del abdomen agudo

SEMIOLOGIA · Clase 30 · McBurney, Blumberg, Rovsing, psoas y obturador

1 · QUÉ ES Y POR QUÉ SE TAPA EL APÉNDICE

Obstrucción de la luz apendicular
casi siempre por un coprolito

le siguen en frecuencia

Otras causas de obstrucción
hiperplasia linfoide, áscaris, oxiuros, cuerpos extraños

cierra la luz y provoca

también cierran la luz y dan

Infección distal e isquemia
inflamación que avanza a necrosis

Abdomen agudo
dolor abdominal reciente, menor de 6 h; exige decidir rápido si hace falta cirugía

su causa quirúrgica más frecuente es la

produce la

Apendicitis aguda
causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico; mayor incidencia entre 20 y 30 años

antes del dolor hay

2 · POR QUÉ EL DOLOR MIGRA Y CÓMO SE PRESENTA

Fiebre de 37,5-38 °C
aparece horas después del dolor

horas después aparece la

si en cambio precede al dolor

Fiebre alta que precede al dolor
orienta más a un origen renal o pulmonar

la distensión causa un

Dolor visceral
la distensión estira la pared: dolor epigástrico mal localizado

al tocar el peritoneo parietal, pasa a

Dolor migratorio
al tocar el peritoneo parietal pasa a la fosa ilíaca derecha; presente en el 100%

Anorexia
previa al cuadro

Náuseas y vómitos
de tipo reflejo

por vía refleja da

completan la

completa la

junto a lo que lo acompaña da la

Sospecha de apendicitis
dolor migratorio con anorexia, náuseas o vómitos

se apoya en la

a la inspección puede mostrar

3 · PUNTOS DOLOROSOS: CADA UNO ORIENTA A UN ÓRGANO

se localiza con los

Puntos dolorosos F2
sitios de la pared donde la presión duele si el órgano de debajo está enfermo

en la mitad xifo-umbilical

Punto epigástrico F2
mitad de la línea xifo-umbilical: úlcera péptica

bajo el reborde costal derecho

Punto cístico F2
reborde costal con borde del recto derecho: colecistitis

en el borde externo de los rectos

Puntos ureterales F2
borde externo de los rectos: cólico renal

en la fosa ilíaca derecha

Punto de McBurney F2
unión del tercio externo con los dos tercios internos de la línea EIAS-ombligo: apendicitis

la posición se integra en la

4 · SIGNOS CON NOMBRE PROPIO

Chutro
cicatriz umbilical desviada hacia la derecha

apoya la

según la posición del apéndice, el

Obturador
decúbito dorsal + flexión de pierna y muslo + rotación interna; duele el hipogastrio

si es positivo sugiere

Apéndice pélvico o retrocecal
lo sugiere el obturador positivo

se explora con la

Blumberg: cómo se hace F1
comprimir lenta y progresivamente, mantener y retirar la mano bruscamente

si soltar duele más, es

Blumberg positivo F1
dolor que aparece o aumenta al soltar; irritación peritoneal (apendicitis, peritonitis)

se explora a distancia con

con elevación del miembro hace el

apoya la

Rovsing F3 · F4
comprimir la fosa ilíaca izquierda desplaza el gas del colon hacia el ciego

si duele el lado derecho

Rovsing positivo F3 · F4
dolor en la fosa ilíaca derecha: sugiere apendicitis aguda

si no duele

Rovsing negativo
no descarta apendicitis

por eso no decide sola la

según la posición del apéndice, el

apoya la

la posición se integra en la

Psoas
decúbito lateral izquierdo + extensión pasiva del muslo derecho; duele la fosa ilíaca derecha

si es positivo sugiere

Apéndice retrocecal
lo sugiere el psoas positivo

Meltzer (Hausmann) F5
dolor en McBurney al elevar el miembro inferior derecho extendido; sugiere apéndice retrocecal (no está en la teoría)

como el psoas, sugiere

5 · EXÁMENES E INTERPRETACIÓN

se estudia con el

si hay duda, puede sumarse la

Temperatura rectal-axilar
la rectal supera a la axilar en 0,8-1 °C; 39-40 °C sugiere peritonitis

Hemograma
10.000-15.000 leucocitos con neutrofilia >75%

Ecografía
no es de rutina; sensibilidad de 75-90%

si sube por encima de 15.000

apoya la

apoya la

con su sensibilidad apoya la

Sugiere perforación
>15.000 leucocitos y neutrofilia >80%

Interpretación conjunta
maniobras, temperatura, hemograma y ecografía apoyan el diagnóstico; ningún signo aislado lo excluye

indica el

Tratamiento quirúrgico oportuno
evita la progresión a perforación y peritonitis

porque ya se produjo la

si no se opera a tiempo

6 · SI SE DEMORA: COMPLICACIONES

Demora del tratamiento
permite extensión local, perforación y complicaciones sistémicas

si el foco se rompe

si el epiplón bloquea el foco

Plastrón apendicular
epiplón y asas vecinas bloquean el foco antes de que se perfore

Perforación
contamina el peritoneo

primero produce una

puede causar

puede dejar un

Peritonitis localizada

Íleo paralítico

Absceso intraabdominal o subdiafragmático

se controla con la

si se extiende pasa a

se detecta con la

Peritonitis generalizada
abdomen en tabla, fiebre 39-40 °C

se detecta con la

se previene con la

Cirugía oportuna y vigilancia
previenen la progresión y detectan secuelas

síndrome · causa · mecanismo · síntoma · signo · ejemplo · concepto · técnica · diagnóstico · complicación · desenlace · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 09f · Dr. Sotomayor, Semiología 2020 y Sotito 2018, más 09b (puntos dolorosos y Blumberg) — teoría del docente (= literatura)